Bienestar Medellín IA

Guía de entrega y ficha de hallazgos · Hackathon de Datos 2026 · Institución Universitaria ITM · Temática: Salud y bienestar

Equipo	**[POR COMPLETAR]** [NOMBRE DEL EQUIPO]
Categoría	**[POR COMPLETAR]** [Interna o Externa]
Integrantes	**[POR COMPLETAR]** [Nombre integrante 1] ([Programa / IES])
Líder y contacto	**[POR COMPLETAR]** [Nombre del líder] · **[POR COMPLETAR]** [correo del líder]
Modalidad	Pipeline automático (fase 2: asistente y portal interactivo sobre sus resultados)
Repositorio público	https://github.com/watabares/medellin-bienestar-datos
Artefacto en línea	https://watabares.github.io/medellin-bienestar-datos/

1. Pregunta que responde el proyecto

¿Cómo usar el análisis de datos para identificar factores ambientales, sociales y territoriales que afectan la salud y el bienestar de Medellín, y por dónde empezar a intervenir?

2. Hallazgo principal

La Candelaria tiene una tasa de mortalidad de **1.325,6** por 100.000 habitantes (2022), **4,58 veces** la de Corregimiento de Santa Elena (289,5), y **aumentó 44,6 %** entre 2012 y 2022.

Fuente: MEData · Secretaría de Salud de Medellín. Asociación, no causalidad.

1.325,6	4,58 x	+44,6 %	648
Mayor tasa de mortalidad La Candelaria · 2022	Brecha entre el mayor y el menor territorio	Variación 2012-2022 de la comuna con mayor tasa	Tasa de toda la ciudad (por 100.000 hab.)

3. Ficha de hallazgos

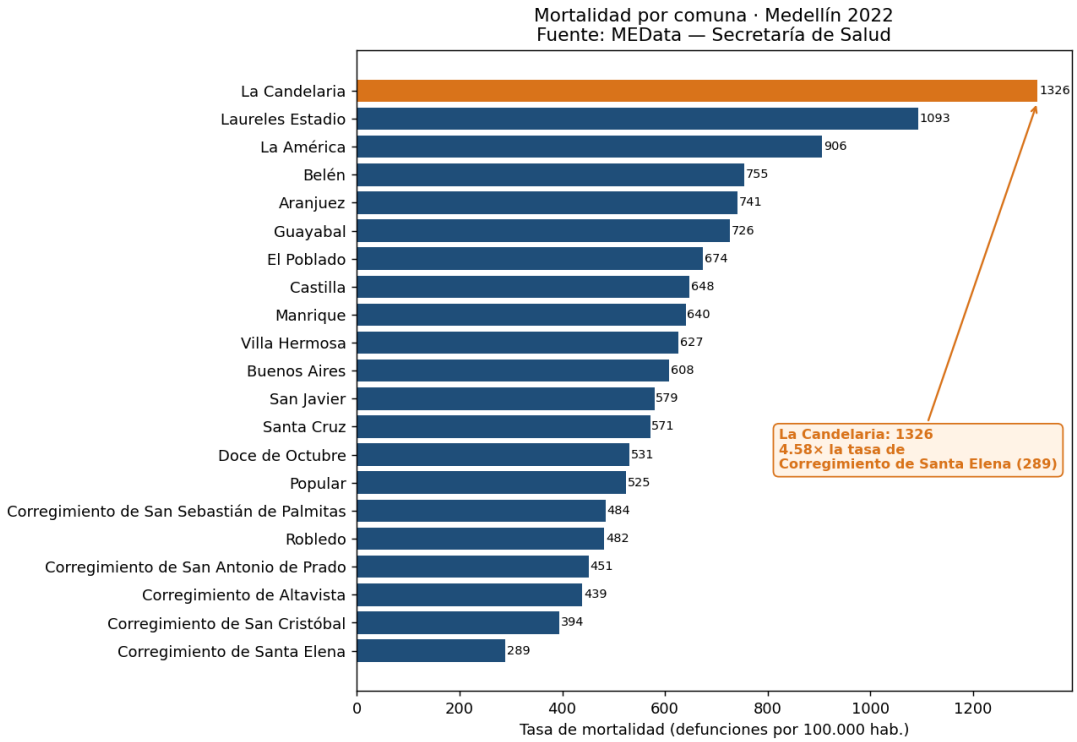
Cada hallazgo se calcula automáticamente a partir de los datos oficiales; la columna «Fuente» indica el conjunto de datos.

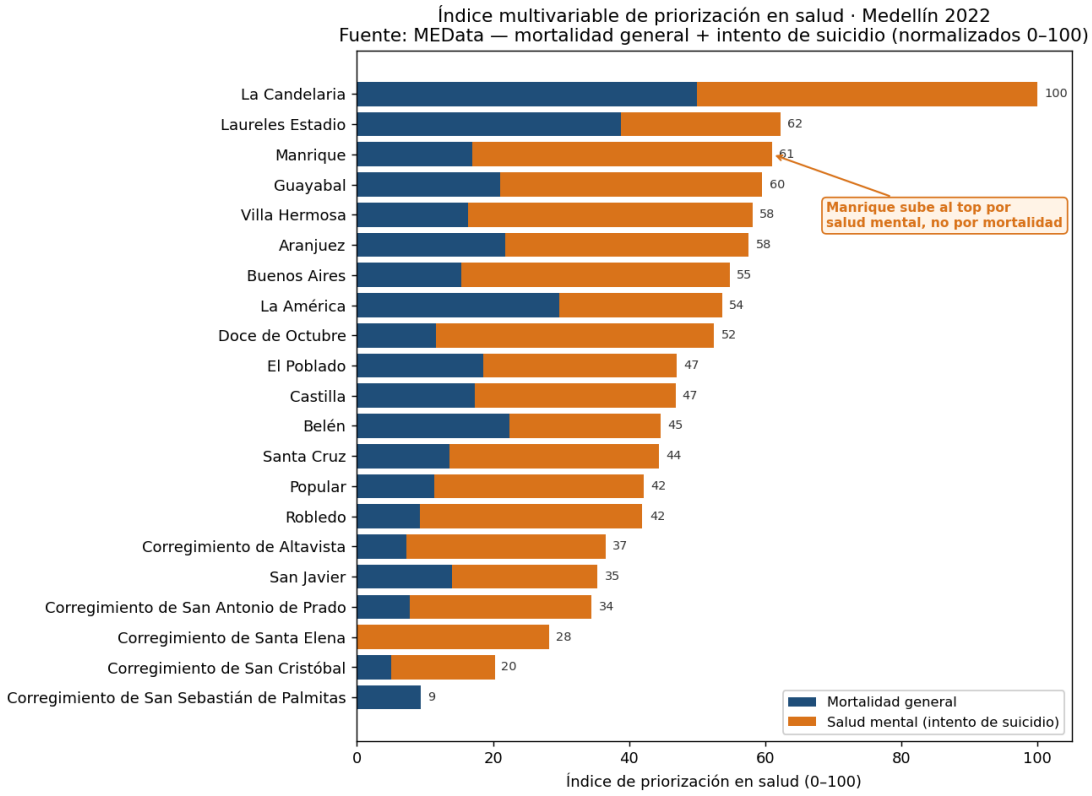
N.º	Hallazgo	Cifra	Fuente
1	Desigualdad territorial en mortalidad general	**4,58 x** entre La Candelaria (1.325,6) y Corregimiento de Santa Elena (289,5) · 2022	MEData · Mortalidad
2	La mortalidad de La Candelaria creció en la última década	**+44,6 %** 2012-2022; pico en 2021 (COVID-19)	MEData · Mortalidad
3	Índice de priorización (mortalidad + salud mental, 0-100): los tres territorios de mayor prioridad	**La Candelaria (100,0), Laureles Estadio (62,2), Manrique (61,0)**	MEData · Mortalidad e Intento de suicidio
4	Manrique entra al top 3 por salud mental, no por mortalidad	Mortalidad normalizada 33,9 · salud mental normalizada 88,2	MEData · Intento de suicidio
5	«Doble carga»: territorios sobre la mediana en mortalidad e intento de suicidio	**5 de 21**: La Candelaria, Manrique, Guayabal, Villa Hermosa, Aranjuez. Correlación de Pearson r = 0,34	MEData · Mortalidad e Intento de suicidio
6	Robustez: la priorización no depende de un peso arbitrario	La Candelaria es nº 1 en **21 de 21** ponderaciones probadas; 6 territorios llegan al top 3 en algún escenario	Cálculo propio sobre el índice
7	Calidad del aire (PM2.5) como contexto ambiental, por estación	23 estaciones en 2025; máximo CEN-TRAF = **24,1 µg/m³**. Todas superan la guía anual de la OMS (5 µg/m³). 20 de 21 estaciones mejoraron frente a 2024 (promedio 18,0 -> 15,2 µg/m³).	SIATA · Datos validados

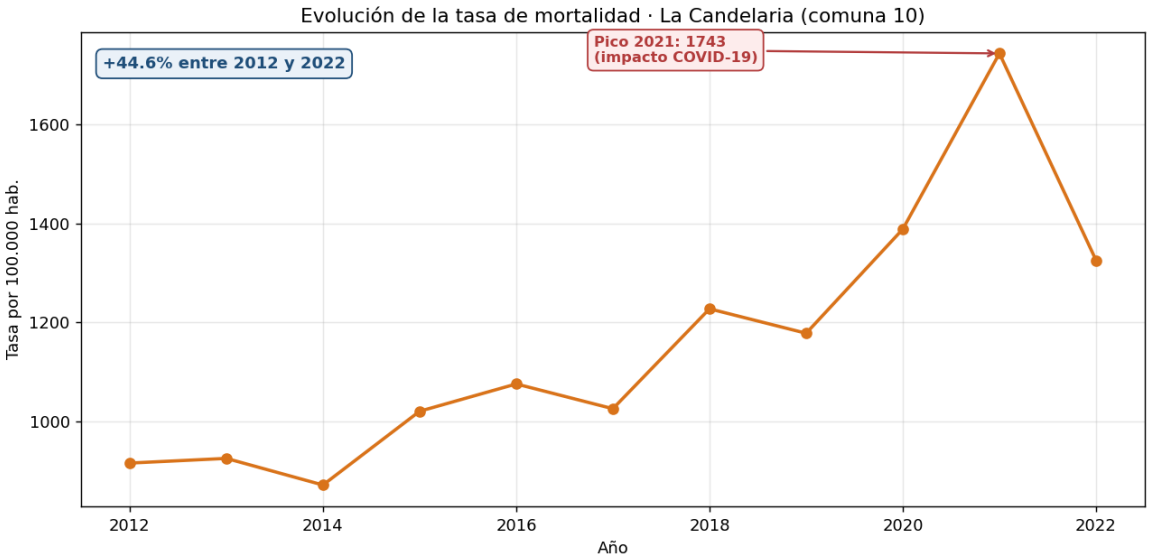
4. Propuestas de mejora

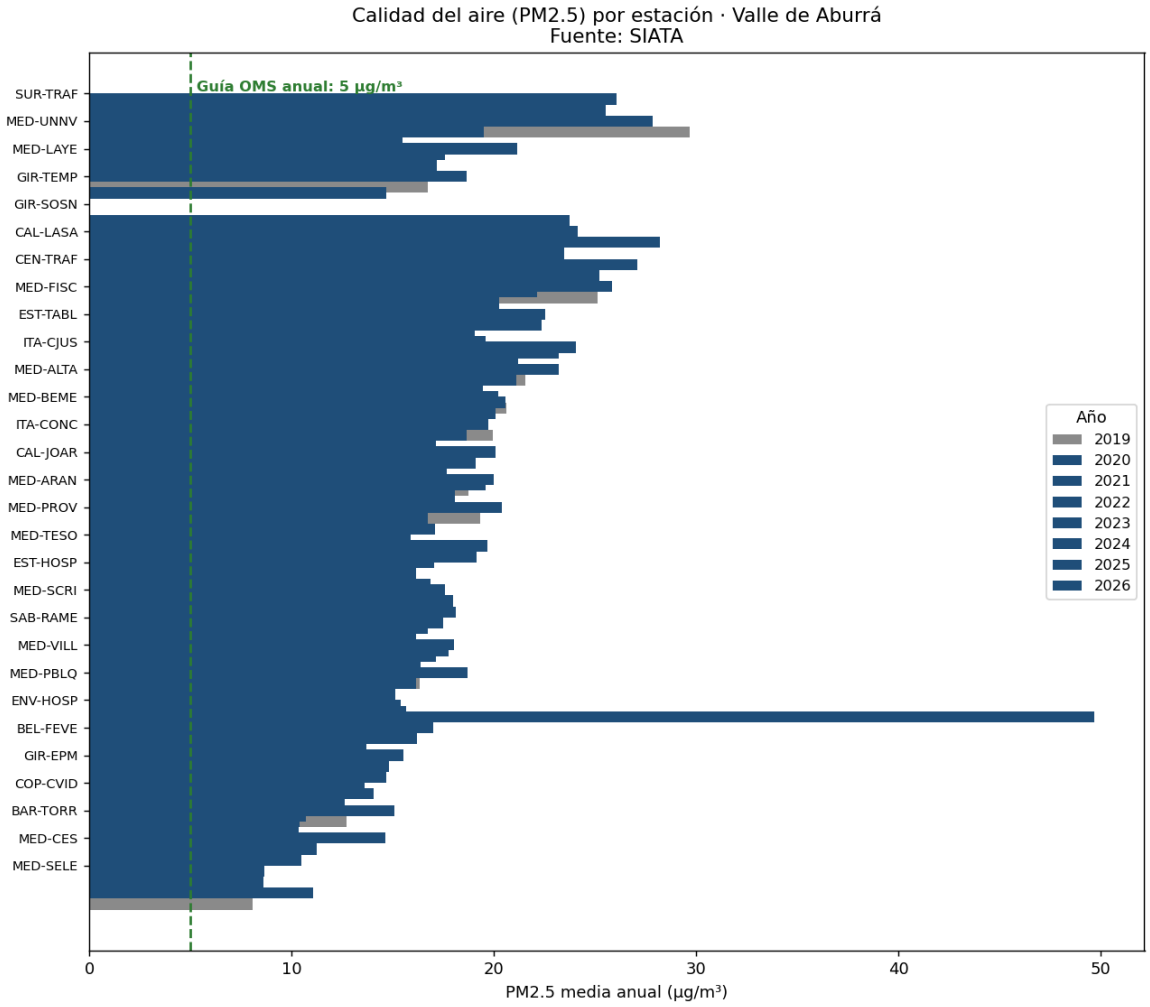
N.º	Propuesta	Acción concreta	Indicador de seguimiento
1	**Programa integral de salud física y mental en los territorios de mayor prioridad**	Concentrar intervenciones intersectoriales en La Candelaria, Laureles Estadio, Manrique, combinando promoción de la salud y atención en salud mental.	Tasa de mortalidad e intento de suicidio por comuna; índice de priorización (anual).
2	**Atención específica de salud mental donde coinciden las dos cargas**	Priorizar rutas de salud mental en La Candelaria, Manrique, Guayabal, Villa Hermosa, Aranjuez.	Tasa de intento de suicidio (SIVIGILA, MEData); cobertura de atención.
3	**Seguimiento automático y comparable en el tiempo**	Mantener el pipeline mensual y sumar tasas estandarizadas por edad para comparar comunas con estructuras de población distintas.	Actualización del portal; tasa ajustada por edad.
4	**Cruzar calidad del aire y salud a escala territorial**	Validar un mapeo espacial estación-comuna para poder incorporar el PM2.5 al índice; hoy se reporta por estación.	PM2.5 por comuna; asociación con indicadores respiratorios (cuando existan datos).

5. Evidencia gráfica









SIATA mide por estación, no por comuna: contexto ambiental (no se atribuye a comunas).

6. Datos, fuentes y licencias

Conjunto de datos	Entidad / identificador	Licencia / condiciones
MEData · Mortalidad (VC_Datos_Enfermedades, capa 3), 2012-2022	Secretaría de Salud de Medellín · id 1-026-22-000161	CC BY 4.0 (verificada en la ficha MEData)
MEData · Intento de suicidio (capa 2), SIVIGILA, 2013-2022	Secretaría de Salud de Medellín · id 1-026-22-000146	CC BY 4.0 (verificada en la ficha MEData)
MEData · otras 8 capas por comuna: natalidad, dengue, hepatitis A, parotiditis, tosferina, tuberculosis pulmonar, varicela, violencia de género (2008/2012/2013-2022)	Secretaría de Salud de Medellín · mismo servicio	Ver la ficha de cada evento en MEData
ECV · Serie histórica de indicadores por territorio, 2007-2022	Alcaldía de Medellín, Planeación	Misma condición que la ECV; se excluyen los indicadores marcados «no publicar» por la fuente
Encuesta de Calidad de Vida 2022-2025 (solo conteos agregados: cobertura y llave de 21 territorios)	Alcaldía de Medellín, Planeación · ficha MEData id 1-002-09-000040	CC BY 4.0 según la ficha de la misma encuesta (cobertura 2011-2019); las bases 2022-2025 vienen del centro documental, que no repite la licencia
SIATA · PM2.5 validado, años completos desde 2020, por estación	SIATA · Valle de Aburrá · siata.gov.co/IDEAM	Sin licencia publicada en su sitio; se atribuye la fuente

Atribución: Alcaldía de Medellín, Secretaría de Salud, MEData. Los microdatos no se publican; solo se versionan tablas agregadas, sin datos personales ni datos sintéticos.

7. Limitaciones

• Asociación, no causalidad: no se hacen afirmaciones causales.
• Tasas brutas, sin estandarizar por edad; pueden sobrerrepresentar comunas con población mayor.
• El PM2.5 se mide por estación y no se atribuye a comunas sin un mapeo espacial validado; por eso no entra al índice.
• MEData publica sus series por comuna hasta 2022; el aire tiene años completos válidos desde 2020: las series no se mezclan en una sola cifra.
• Los factores asociados son correlaciones entre 21 territorios, sin ajustar por edad: describen patrones, no causas.
• La población por territorio se deriva de casos / tasa; sirve para la tasa de ciudad y no sustituye proyecciones oficiales del DANE.

8. Automatización y reproducibilidad

El pipeline (GitHub Actions: push, ejecución manual y cron mensual) descarga las fuentes oficiales, valida la llave territorial, limpia, integra, analiza, visualiza, construye la base de conocimiento, ejecuta las pruebas del asistente y publica el portal, sin pasos manuales. Instrucciones de prueba: **instrucciones.txt** en la raíz del repositorio.

9. Uso de inteligencia artificial

• **Kiro CLI** (asistente de programación con IA): desarrollo de scripts, portal y documentación; el equipo revisa y puede explicar el resultado.
• **ChatGPT y Gemini**: consultas exploratorias iniciales (ideas y búsqueda de fuentes); no generaron código ni cifras.
• **Asistente del portal**: las cifras salen siempre de un motor determinista que lee la base de conocimiento. Las preguntas escritas se interpretan con **Google Gemini** (capa gratuita, vía un Worker de Cloudflare), que solo devuelve el tipo de consulta y los territorios, de listas cerradas; nunca cifras. Si la IA falla, responde el motor solo.
• La capa opcional con un modelo de OpenAI (asistente/llm.py) está apagada por defecto y no se usa en el portal publicado.

Cifras generadas desde knowledge_base.json (última actualización 2026-11-06 03:34 UTC). Guía creada el 2026-11-06.